Buổi 7 (BẢO VỆ & VIẾT: đạo đức, liêm chính, Phương pháp và Kết quả): Phiếu bài tập

Nền tảng Nghiên cứu Lâm sàng · Cấp độ 1 · Neudata · *#ClearDataClearImpact* · Tuần 7 · Thứ Bảy 12/12/2026 · trực tuyến, 19:30–22:30

Họ và tên: _____ **Khoa/Phòng:** _____

Gõ câu trả lời vào tệp Word này hoặc in bản PDF.

Phần	Nhiệm vụ	Khi nào
A	Tình huống liêm chính: xanh, vàng hay đỏ?	Cuối phần 7.2, hoàn thành ở nhà
B	Xây dựng đề cương 7: viết Phần 4 của đề cương (đạo đức, đăng ký, tính khả thi, kế hoạch công bố)	Trên lớp, trước giờ giải lao. Phần còn lại: ở nhà
C	**Thực hành bản thảo 1**: viết phần Kết quả cho câu hỏi FLUID-ICU của riêng bạn	Sau phần 7.3 (45 phút), hoàn thành ở nhà

Các tệp bạn cần (gửi qua email): gói kết quả của câu hỏi bạn chọn (`Results_Pack_QN_VN.pdf`), mẫu bản thảo (`Manuscript_Template_IMRaD_VN.docx`), Bài báo 1 (Boulet 2024) và Bài báo 2 (Hyun 2023).

Phần A: Tình huống liêm chính: xanh, vàng hay đỏ?

Nhiệm vụ. Với mỗi tình huống, chọn một màu và viết một câu giải thích vì sao. Trên lớp, tự làm tình huống 1, 3, 4a và 4b, rồi bình chọn và chuẩn bị nêu lý do khi giảng viên mời. Tình huống 2, 5 và 6 làm ở nhà.

> **Chọn từ: XANH** = chấp nhận được như mô tả · **VÀNG** = chấp nhận được **chỉ khi** sửa hoặc công khai một điều gì đó (nói rõ điều gì) · **ĐỎ** = hành vi sai trái trong nghiên cứu hoặc vi phạm nghiêm trọng. Không được làm.

#	Tình huống	Màu	Vì sao?
1	Phiếu theo dõi dịch ngày 3 của ba người bệnh bị mất. Một bác sĩ nội trú "nhớ đại khái" cân bằng dịch của họ và nhập các giá trị đó để bộ dữ liệu được đầy đủ.		
2	Sau khi xem kết quả, nhóm nghiên cứu loại hai người bệnh có giá trị dịch "lạ" vì họ làm yếu mối liên quan. Bài báo không đề cập việc này.		
3	Trưởng khoa không tham gia nghiên cứu nhưng đề nghị đứng tên tác giả cuối "vì đây là khoa của tôi".		
4a	Một điều dưỡng dùng chatbot AI để cải thiện tiếng Anh cho phần Bàn luận do chính cô viết, kiểm tra từng câu, và nêu rõ điều này trong phần Lời cảm ơn.		
4b	Một đồng nghiệp tải bảng tính của nghiên cứu (có cả họ tên và mã số bệnh viện) lên một chatbot công cộng miễn phí và nhờ nó "chạy thống kê".		
5	Một nghiên cứu thuần tập trên người bệnh sepsis giống FLUID-ICU được công bố thành ba bài báo (tử vong, tổn thương thận cấp và thời gian nằm ICU) trên ba tạp chí, không bài nào nhắc đến các bài kia.		
6	Hai đoạn văn của một bài tổng quan đã công bố được chép nguyên văn vào phần Đặt vấn đề của bạn. Bài tổng quan được trích dẫn ở cuối đoạn, nhưng không có dấu ngoặc kép.		

Phần B: Xây dựng đề cương 7: đạo đức, đăng ký, tính khả thi và kế hoạch công bố

Nhiệm vụ. Điền phiếu này cho đề cương **của riêng bạn**. Trên lớp, giảng viên điền trước từng khối cho ví dụ xuyên suốt (nghiên cứu thuần tập hồi cứu về cân bằng dịch và tử vong 28 ngày ở người lớn bị sốc nhiễm khuẩn tại ICU của mình). Sau mỗi khối, bạn tự viết câu trả lời của mình và chuẩn bị đọc khi giảng viên mời. Nếu chưa xong trên lớp, làm tiếp phần còn lại ở nhà.

Câu trả lời của bạn sẽ trở thành Phần 4 của đề cương viết và slide 5 (đạo đức và tính khả thi) và slide 6 (kế hoạch công bố) của bài trình bày. Gửi email đề cương viết và 6 slide trước 19:30 thứ Bảy 19/12/2026, Buổi 8 (`Proposal_Brief_VN.pdf`).

B1. Đạo đức và sự đồng ý tham gia

Câu hỏi	Câu trả lời của bạn
Hội đồng đạo đức nào sẽ xét duyệt nghiên cứu? Bạn dự kiến hình thức xét duyệt nào (miễn xét duyệt / xét duyệt rút gọn / xét duyệt đầy đủ)? Hội đồng là bên quyết định.	
Người tham gia là ai, và họ có tự quyết định được khi đủ điều kiện tham gia không?	
Ai đồng ý tham gia (người bệnh / người đại diện hợp pháp / đồng ý trì hoãn / đề nghị miễn đồng ý)? Dùng sơ đồ quyết định về sự đồng ý trong ICU (slide Buổi 7).	
Ai lấy sự đồng ý, khi nào và ở đâu?	
Người tham gia có những nguy cơ và gánh nặng gì, và chúng được giảm thiểu thế nào?	
Nghiên cứu có cần đăng ký không? Thử nghiệm: có, trước người bệnh đầu tiên, trên ClinicalTrials.gov hoặc một hệ thống đăng ký thử nghiệm (registry) khác được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận. Tổng quan hệ thống: PROSPERO. Nghiên cứu quan sát: khuyến khích.	

B2. Bảo mật thông tin

Câu hỏi	Câu trả lời của bạn
Bạn sẽ thu thập những thông tin định danh trực tiếp nào (nếu có), và vì sao?	
Mỗi người bệnh sẽ được cấp mã nghiên cứu như thế nào?	
Tệp định danh (nối mã nghiên cứu với danh tính) được lưu ở đâu, và ai được mở?	
Dữ liệu đã loại bỏ thông tin định danh sẽ được lưu ở đâu (được cơ sở phê duyệt, có mật khẩu bảo vệ)?	

B3. Kiểm tra tính khả thi (đánh dấu và nhận xét)

✓	Câu hỏi	Nhận xét
☐	**Thời gian:** tiến độ thực tế (hội đồng đạo đức 1–3 tháng, thu nhận người bệnh, phân tích, viết bài)?	
☐	**Kinh phí:** đã nêu các khoản mục ngân sách (thời gian nhân lực, vật tư/xét nghiệm, phí công bố)?	
☐	**Nhân lực:** ai thu thập dữ liệu (ban đêm, cuối tuần), ai phân tích, có thời gian dành riêng không?	
☐	**Người bệnh:** năm ngoái khoa bạn có bao nhiêu người bệnh đủ điều kiện? Thực tế bạn có thể thu nhận bao nhiêu người?	
☐	**Dữ liệu:** các biến chính có được ghi nhận thường quy không? Khả năng thiếu bao nhiêu?	

Rủi ro lớn nhất về tính khả thi: _____ Một cách khắc phục: _____

B4. Kế hoạch công bố (slide 6 của bài trình bày)

Mục	Câu trả lời của bạn
Tên đề tài tạm thời (từ PICO: thiết kế, I so với C, P, O, trong 10 đến 16 từ)	
Tạp chí mục tiêu (và một tạp chí dự phòng), đã kiểm tra trên Danh mục Tạp chí Truy cập Mở (Directory of Open Access Journals, DOAJ) và Danh mục của Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ (NLM Catalog), biết rõ phí và giấy phép	
Hướng dẫn báo cáo (CONSORT / STROBE / STARD / PRISMA / SPIRIT / CARE)	
Có cần đăng ký không? Ở đâu? (từ B1)	
Các tác giả (đủ cả bốn tiêu chí của Ủy ban Quốc tế các Biên tập viên Tạp chí Y khoa, ICMJE) và vai trò của họ (Phân loại vai trò người đóng góp, CRediT)	
Xung đột lợi ích và nguồn tài trợ cần công bố	
Tuyên bố chia sẻ dữ liệu (chia sẻ gì, ở đâu, với điều kiện gì)	
Hội nghị nơi bạn sẽ trình bày tóm tắt đầu tiên	

Khung tóm tắt có cấu trúc. Mỗi mục một dòng. Phần Kết quả là kết quả bạn *dự kiến sẽ báo cáo* (định dạng, không phải con số).

Mục	Một dòng
Đặt vấn đề	
Phương pháp	
Kết quả (dự kiến)	ví dụ "tử vong 28 ngày: n/N mỗi nhóm, RR (khoảng tin cậy 95%)"
Kết luận	Viết câu bạn sẽ dùng nếu kết quả dương tính, và câu bạn sẽ dùng nếu không.

Phần C: Thực hành bản thảo 1: phần Kết quả cho câu hỏi của bạn

Nhiệm vụ. Trong toàn bộ thời gian thực hành (45 phút), viết **phần Kết quả cho câu hỏi bạn đã chọn** (Q1 đến Q5), chỉ dùng gói kết quả của câu hỏi đó. Làm lần lượt năm khối bên dưới. Với mỗi khối, bảng cho biết số liệu nằm ở đâu trong gói và đưa ra một câu mẫu của Q1. Câu mẫu Q1 chỉ để minh họa cách viết. Không chép lại, kể cả khi bạn chọn Q1. Khi gặp khó khăn, hỏi giảng viên trong khung chat. Hoàn thành ở nhà và nộp phần Kết quả đầy đủ (xem "Sản phẩm cần nộp" bên dưới).

Thời gian, như trên slide: khối 1 đến 4 (STROBE 13 đến 16) ở phần 1 (25 phút), khối 5 (STROBE 17), danh sách bảng, hình và bước đối chiếu số liệu ở phần 2 (20 phút).

Câu hỏi	Chủ đề	Gói kết quả
Q1	Cân bằng dịch dương đến ngày 3 và tử vong 28 ngày	`Results_Pack_Q1_VN.pdf`
Q2	Cân bằng dịch tích lũy và tổn thương thận cấp (AKI)	`Results_Pack_Q2_VN.pdf`
Q3	Cân bằng dịch tích lũy và số ngày không thở máy	`Results_Pack_Q3_VN.pdf`
Q4	Lactat ban đầu và tử vong 28 ngày, trường hợp đầy đủ so với quy gán đa bội (multiple imputation)	`Results_Pack_Q4_VN.pdf`
Q5	Cân bằng dịch và thời gian nằm ICU ở người sống sót	`Results_Pack_Q5_VN.pdf`

Số liệu nằm ở đâu trong gói của bạn

Các khối theo mục 13 đến 17 của STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology, hướng dẫn báo cáo nghiên cứu quan sát).

Khối	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
1. Người tham gia (13)	Mục 2	Mục 2	Mục 2	Mục 2	Mục 2
2. Đặc điểm ban đầu và dữ liệu thiếu (14)	Bảng 1	Bảng 1	Bảng 1	Bảng 1 và 2, Hình 1	Bảng 1
3. Kết cục ở mỗi nhóm (15)	Bảng 2, Hình 1	Bảng 2 và 3, Hình 1	Bảng 2, Hình 1 và 2	Bảng 3, Hình 2	Bảng 2, Hình 1 và 2
4. Kết quả chính, thô và đã hiệu chỉnh (16)	Bảng 3 và 4, Hình 2 và 3	Bảng 4 (mỗi 10 ml/kg), Hình 2	Bảng 3 (mỗi 10 ml/kg)	Bảng 4 (chưa hiệu chỉnh và đã hiệu chỉnh), Hình 3	Bảng 3 (tuyến tính trên thang log, thô và đã hiệu chỉnh)
5. Các phân tích khác (17)	Bảng 5 và 6, Hình 4	Bảng 4 (dương so với âm, AKI giai đoạn 2 đến 3)	Bảng 3 (dương so với âm, Mann-Whitney)	Bảng 4 (mô hình có SOFA)	Bảng 3 (Mann-Whitney, mỗi 10 ml/kg)

Viết phần Kết quả theo từng khối

Quy tắc cho mọi câu: số liệu đúng như trong gói, tỷ lệ phần trăm kèm n/N, mọi ước lượng kèm khoảng tin cậy 95%, viết ở thì quá khứ, dùng "có liên quan với" và không diễn giải.

Khối	Câu mẫu (Q1, chỉ để minh họa cách viết)	Câu của tôi (câu hỏi của tôi)
1. Người tham gia: số được thu nhận, được phân tích, bị loại, kèm lý do	"Trong 620 người bệnh được thu nhận, 618 người có cân bằng dịch ngày 3 và được phân tích. Mô hình hiệu chỉnh gồm 527 người bệnh có dữ liệu đầy đủ."	
2. Đặc điểm ban đầu và dữ liệu thiếu	"Người bệnh có cân bằng dịch dương có trung vị điểm SOFA cao hơn người có cân bằng dịch âm (8 [IQR 6 đến 10] so với 6 [4 đến 8]). Lactat bị thiếu ở 91 trên 618 người bệnh."	
3. Số kết cục ở mỗi nhóm, kèm mẫu số	"Đến ngày 28, 134 trên 373 người bệnh (35.9%) có cân bằng dịch dương và 45 trên 245 người (18.4%) có cân bằng dịch âm đã tử vong (Bảng 2)."	
4. Kết quả chính: thô và đã hiệu chỉnh, kèm khoảng tin cậy 95%	"Tỷ số chênh (OR) thô cho tử vong là 2.49 (khoảng tin cậy 95% 1.70 đến 3.70). Sau hiệu chỉnh, OR là 1.62 (khoảng tin cậy 95% 1.02 đến 2.59, n = 527) (Bảng 3)."	
5. Các phân tích khác trong gói	"Với quy gán đa bội (n = 620), OR hiệu chỉnh là 1.70 (khoảng tin cậy 95% 1.09 đến 2.64) (Bảng 6)."	

Mọi bảng và hình trong gói của tôi

Liệt kê từng bảng và hình trong gói của bạn. Đánh dấu khi đã đưa vào bản nháp, và ghi chỗ phần lời nhắc đến nó. Phần Kết quả bạn nộp phải có tất cả bảng và hình này (`Manuscript_Brief_VN.pdf`).

Bảng hoặc hình trong gói	Đã có trong bản nháp?	Được nhắc đến trong phần lời (khối)
	☐	
	☐	
	☐	
	☐	
	☐	
	☐	
	☐	
	☐	
	☐	
	☐	

Lưu ý riêng cho từng câu hỏi

- **Q3:** số ngày không thở máy phân bố lệch và tính tử vong là 0.
- **Q4:** báo cáo cả ước lượng trường hợp đầy đủ và quy gán đa bội.
- **Q5:** chỉ người sống sót. Dùng trung vị và khoảng tứ phân vị (IQR).

Hoàn thành ở nhà

- ☐ Viết đủ năm khối, với mọi kết quả trong gói
- ☐ Mọi bảng và hình trong gói đều có mặt, được nhắc đến trong phần lời và tự đọc hiểu được (tên, đơn vị, n, chữ viết tắt)
- ☐ Không diễn giải ("vì", "gợi ý rằng") và không dùng từ nhân quả
- ☐ Tên bài dự kiến và câu công khai sử dụng AI

Phương pháp (học ở 7.3, không bắt buộc nộp)

Nếu bạn nộp thêm phần Phương pháp, dùng mục 4 đến 12 của STROBE: thiết kế và bối cảnh, người tham gia, biến số, nguồn dữ liệu, sai lệch, cỡ mẫu ("mọi người bệnh đủ tiêu chuẩn trong nghiên cứu thuần tập đều được đưa vào"), phương pháp thống kê và dữ liệu thiếu. Thông tin có trong gói kết quả, kế hoạch phân tích thống kê (`SAP_FLUID-ICU_VN.pdf`) và `Data_Dictionary_VN.pdf`.

Sản phẩm cần nộp

Phần Kết quả của bạn, đặt tên `Surname_Firstname_Results_QN.docx`, gửi email cho người bình duyệt của bạn và giảng viên Vương Mỹ Lượng (myluong1710@gmail.com) **trước 23:59 Chủ nhật 20/12/2026 (giờ Việt Nam)**. Phần này báo cáo tất cả kết quả trong gói của bạn (`Manuscript_Brief_VN.pdf`). Người bình duyệt của bạn được công bố cuối buổi học hôm nay.